

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5093703-85.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: CATIA CILENE SOUZA DA SILVA DE ALMEIDA

MEDIDA DE URGÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AFLIBERCEPTE 40MG/ML (EYLIA®). RECURSO DA UNIÃO. URGÊNCIA DA MEDIDA DEMONSTRADA. RISCO DE CEGUEIRA. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA E CONSTANTE DO DISPENSÁRIO DO SUS. USO FORA DA BULA. INEXISTÊNCIA DE MEDICAMENTO EQUIVALENTE NO DISPENSÁRIO PARA A INDICAÇÃO DE MÉDICO DO SUS. RECURSO DA UNIÃO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO para manter a decisão impugnada. Sem custas. Sem honorários. Intimem-se as partes e, após o decurso do prazo recursal, sem manifestação, devolvam-se os autos à origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2024.

5093703-85.2024.4.02.5101

510015111862 .V4

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5093703-85.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: CATIA CILENE SOUZA DA SILVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta pela União em face da decisão que deferiu a tutela de urgência para fornecimento do medicamento Aflibercepte 40mg/mL (Eylia®).

Segue a decisão:

Trata-se de ação proposta pela parte autora, CATIA CILENE SOUZA DA SILVA DE ALMEIDA, contra a parte ré, UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO e MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI, por meio da qual pretende a concessão de tutela liminar de urgência para que as rés sejam obrigadas a fornecerem o fármaco ABLIBERCEPTE - 03 ampolas de 40Mg/ ML.

Sobre os fatos e fundamentos que servem de supedâneo a seu pedido, narra que está com edema de mácula cistoide do olho direito CID 10 H 35.0. Perdeu boa parte da capacidade visual. Viu comprometida sua atividade profissional, pois é costureira. O médico que a assiste prescreveu u uso urgente do fármaco, ABLIBERCEPTE, contudo a autora não tem condições financeiras para aquisição, tendo em vista o tratamento ser no valor de R\$ 11.980,44 (onze mil novecentos e oitenta reais e quarenta e quatro centavos).

PARECER TÉCNICO/SES/SJ/NATJUS-FEDERAL Nº 1538/2024, evento 12.1, informa que o medicamento pleiteado pela parte autora, ABLIBERCEPTE - 03 ampolas de 40Mg/ ML, tem indicação em bula para a enfermidade que a acomete. Está incorporado ao SUS, porém está incorporado ao SUS para tratamento de outras enfermidades oculares, que não a da autora, por isso a mesma não tem como conseguir a medicação pelo SUS. Não existe no mercado, para tratamento de edema de mácula cistóide do olho, outra medicação equivalente.

O Juízo determinou, evento 14.1, que fosse juntada aos autos documentação complementar, de modo a atender ao determinado no Enunciado n. 35 do CJF.

A parte autora junta aos autos laudo médico recente, evento 18.1.

É o breve relatório. DECIDO

INDEFIRO a gratuidade de justiça, tendo em vista a parte autora não ter juntado aos autos declaração de hipossuficiência.

O Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária de 17/03/2010, no Agravo Regimental na Suspensão de Tutela Antecipada 175, definiu alguns parâmetros para solução judicial dos casos que envolvem direito à saúde:

(a) a inexistência de tratamento/procedimento ou medicamento similar/genérico oferecido gratuitamente pelo SUS para a doença ou, no caso de existência, sua utilização sem êxito pelo postulante ou sua inadequação devido a peculiaridades do paciente;

(b) a adequação e a necessidade do tratamento ou do medicamento pleiteado para a doença que acomete o paciente;

(c) a aprovação do medicamento pela ANVISA; e

(d) a não configuração de tratamento experimental.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça definiu, no âmbito do REsp nº 1.657.156 (Tema Repetitivo 106), as diretrizes para fornecimento de fármacos não incorporados em atos normativos do SUS:

"A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência". Tese definida no acórdão dos embargos de declaração publicado no DJe de 21/9/2018

(STJ, REsp nº 1.657.156, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 04/05/2018).

Ainda, nesse sentido enunciado da III JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE:

ENUNCIADO Nº 75

Nas ações individuais que buscam o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde - SUS, sob pena de indeferimento do pedido, devem ser observados cumulativamente os requisitos estabelecidos pelo STJ, no julgamento do RESP n. 1.657.156, e, ainda, os seguintes critérios:

I) o laudo médico que ateste a imprescindibilidade do medicamento postulado poderá ser infirmado através da apresentação de notas técnicas, pareceres ou outros documentos congêneres e da produção de prova pericial;

II) a impossibilidade de fornecimento de medicamento para uso off label ou experimental, salvo se houver autorização da ANVISA;

III) os pressupostos previstos neste enunciado se aplicam a quaisquer pedidos de tratamentos de saúde não previstos em políticas públicas.

Dentre os requisitos para concessão do medicamento, a parte autora demonstrou:

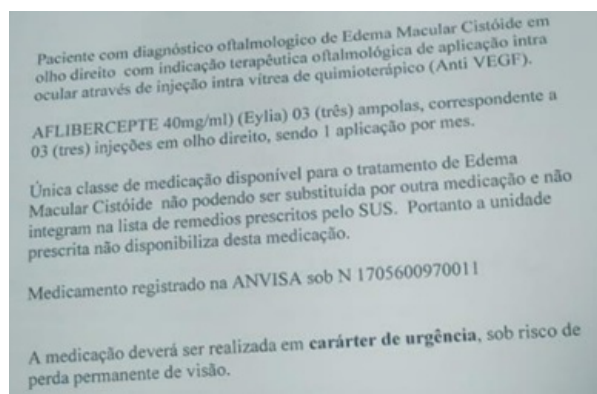
a) hipossuficiência financeira para arcar com o custo do medicamento prescrito, tendo em vista seu elevado valor (R\$ 4.329,50), sendo a autora tratada pelo SUS, o que faz presumir não ter recursos para arcar com uma medicação desse valor;

b) que o medicamento possui registro na ANVISA e está indicado em bula para o tratamento clínico do quadro apresentado pela Autora, conforme Parecer NATJUS (evento 12.1).

c) laudo médico que ateste a imprescindibilidade do medicamento (evento 18.2);

Com efeito, verifico que constam dos autos provas no sentido de que a autora foi diagnosticada com **edema macular cistoide em olho direito**. Tendo sido indicada terapêutica oftalmológica de aplicação intravítrea do quimioterápico (anti-VEGF) Aflibercepte 40mg/mL (Eylia®), na posologia de 03 injeções em olho direito, com intervalo mensal entre as aplicações, que devem ser realizadas em caráter de urgência, perante risco de perda permanente da visão.

A parte autora juntou aos autos, evento 18.2, laudo médico oftalmológico do Hospital do Olho de Duque de Caxias (SUS), que relata o abaixo colacionado.



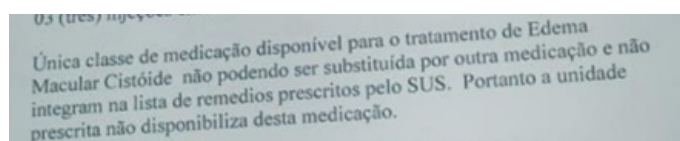
O NAT informou que o medicamento Aflibercepte 40mg/mL (Eylia®) é um fragmento de anticorpo monoclonal que age ligando-se seletivamente a uma proteína chamada fator de crescimento endotelial vascular. E possui indicação para a condição clínica que acomete a Autora (Evento 12.1).

Verifico que o medicamento Aflibercepte 40mg/mL (Eylia®) possui registro na ANVISA, bem como foi incorporado ao SUS para o tratamento do edema macular diabético (EMD), conforme protocolo do Ministério da Saúde e a assistência oftalmológica no SUS (Evento 12.1), porém não foi incorporado ao SUS para tratar o edema macular cistoide, não tendo a autora como ter acesso ao fármaco pelo SUS.

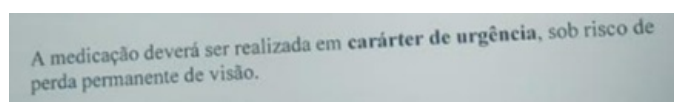
Dos requisitos para tutela antecipada. Há probabilidade do direito pleiteado. A Constituição garante no art. 196 que:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

No caso concreto a autora já foi submetido a outras alternativas terapêuticas sem sucesso no tratamento. No momento, o único tratamento possível para a autora é o uso do medicamento Aflibercepte 40mg/mL (Eylia®), conforme afirmado pela equipe médica que a trata, evento **18.2**.



Por sua vez, há perigo de dano à saúde e à qualidade de vida da parte autora, uma vez que a demora no tratamento abre espaço para a progressão da doença, levando-a à perda de visão no olho direito.



Deve, portanto, a autora receber o medicamento Aflibercepte 40mg/mL (Eylia®).

Isso posto, **DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA** para determinar que os réus promovam, no prazo de 20 (vinte) dias, a entrega à parte autora do medicamento Aflibercepte 40mg/mL (Eylia®), conforme prescrição médica (laudo evento 18.2) e eventuais insumos necessários à sua administração.

Não foram apresentadas contrarrazões.

VOTO

O processo principal foi distribuído em 12-6-2024, assim não há que se determinar a competência para o seu julgamento com base no Tema 1234.

No que diz respeito à tutela de urgência concedida, trata-se de medicamento incorporado, mas com indicação médica fora da bula (*off label*), sem alternativo constante das listas de fornecimento do SUS. Assim concluiu o NAT:

A Autora apresenta diagnóstico de oclusão de ramo de veia central da retina com edema macular em olho direito. Foi indicado tratamento com aplicações do medicamento Aflibercepte (Eylia®).

2. Neste sentido, cumpre informar que o Aflibercepte 40mg/mL (Eylia®) possui indicação que consta em bula para a condição clínica que acomete a Autora - oclusão de ramo de veia central da retina com edema macular em olho direito³.

3. Quanto à disponibilização no âmbito do SUS, informa-se que o Aflibercepte foi incorporado ao SUS para o tratamento do edema macular diabético (EMD) e degeneração macular relacionada à idade forma exsudativa, conforme protocolos do Ministério da Saúde e a assistência oftalmológica no SUS. Contudo, a doença da Autora - oclusão de ramo de veia central da retina com edema macular - não foi contemplada para o acesso ao medicamento, inviabilizando o seu recebimento pela via administrativa.

4. O medicamento Aflibercepte (Eylia®) não foi avaliado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) para o tratamento da oclusão de ramo de veia central da retina com edema macular⁴.

5. Ressalta-se que não há medicamentos que configurem alternativas terapêuticas disponibilizados no âmbito do SUS frente ao medicamento pleiteado Aflibercepte para tratamento da doença da Suplicante.

6. O Aflibercepte (Eylia®) possui registro ativo na Agência Nacional de Vigilância sanitária (ANVISA).

A urgência do medicamento foi atestada por médico do Hospital do Olho Júlio Cândido de Brito, entidade municipal de saúde (<https://duquedecaxias.rj.gov.br/noticia/esse-e-o-novo-numero-da-central-de-agendamento-do-hospital-do-olho-julio-candido-de-brito/383>) diante do risco de perda da visão, em razão do edema macular cistóide que acomete a paciente Cátia Cilene Souza da Silva de Almeida.

Portanto, a tutela foi deferida com base em laudo médico e, diante do risco, deve ser mantida.

Por fim, a receita, prescrita por médico do SUS e por médico do Hospital do Olho (evento 1, DOC3), este indicando a aplicação de três ampolas. O NAT, por sua vez, afirma não haver fármaco equivalente no dispensário do SUS para o tratamento com indicação fora da bula.

Portanto, foi demonstrada a urgência do uso do medicamento.

Pelo exposto, VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO para manter a decisão impugnada. Sem custas. Sem honorários. Intimem-se as partes e, após o decurso do prazo recursal, sem manifestação, devolvam-se os autos à origem.